

VIVIEN LEAD MAGNET

A demencia- kommunikáció kompetens kódexe

*Szakmai referencia — egy szintézis a
Validation, Positive Approach és Person-
Centred Care alapján*

KÉSZÍTETTE

Stoiber Vivien

Demenciaszakértő · A demenciáról érthetően

DEMENCIAROLERTHETOEN.HU

A demencia-kommunikáció kompetens kódexe

Szakmai szintézis — Kitwood, Feil, Snow és a DEEP magyar adaptációval

Egy kollegiális referencia geriáterekek, ápolásvezetőknek, gyógytornászoknak és demencia-szakértőknek arról, hogyan illeszkedik össze a négy nagy nemzetközi iskola a magyar gyakorlatban.

Stoiber Vivien — demenciaeducátor, gyógytornász

Mielőtt belevágsz

Kedves Kolléga,

ha ezt a kódexet a kezébe vetted, valószínűleg te is azok közé tartozol, akiknek a hétköznapijába rendszeresen belép egy demenciával élő ember és a családja — geriáterként, neurológusként, ápolásvezetőként, gyógytornászként, szociális szakemberként vagy demencia-mentorként. És valószínűleg te ezt már jobban tudod nálam. Mégis elkészítettem ezt a szintézist — három okból.

Az első: a magyar demencia-szakmában feltűnően kevés az olyan írott referencia, ami a négy nagy iskolát — Kitwood person-centred care, Feil validation, Snow Positive Approach to Care, és a DEEP-mozgalom érintetti-perspektíváját — együtt nézi. Külön-külön mindenki ismeri őket. Az ütközéseik, az átfedéseik és a magyar kontextusra való adaptációjuk ritkán kerül egy lapra.

A második: a hozzátartozóknak adott edukáció minőségét az határozza meg, hogy mi, szakemberek mennyire koherensen beszélünk. Ha az egyik kolléga azt mondja, korigálj nyugodtan, a másik azt, menj bele a tévképzetébe, a harmadik antipszichotikumot ajánl — a család összezavarodik. Ez a kódex egy közös szakmai nyelv felé indulás.

A harmadik: kollegiális ajánlat. A füzet végén nem páciens-toborzó CTA van, hanem egy szakmai szupervízió-kör és ko-edukációs együttműködés. Sokszor a kompetens emberek a legkevésbé láthatók ebben a térben — ezt szeretném oldani.

A formátumról: tegezlek, mert a magyar demencia-szakmában a kollegialitást fontosabbnak tartom a formális távolságnál. Ahol vitatható a magyar terminológia, ott jelzem — nem ex cathedra állítok.

Az alábbi 7 helyzetnél mindegyiknél négy dolgot nézünk meg:

- **A helyzet a gyakorlatból.**
- **Mit mond a négy iskola.** (Kitwood, Feil, Snow, DEEP röviden)
- **A magyar adaptáció.**
- **Amit kollegiálisan megosztok.**

Vivien

A három alapelv

A négy nemzetközi iskolának (Kitwood, Feil, Snow, DEEP) van három közös magja, ami minden későbbi technikát megelőz. Ezt érdemes elől tartani.

1. A személy elsőbbsége a tünet előtt

Kitwood központi tétele — personhood first — ma a NICE-, WHO- és Alzheimer Europe-irányelvek hivatalos kerete. Az érintett nem a diagnózisa: egy egykori tanár attól még tanár, hogy nem emlékszik a múlt heti óratervre. A károsító kapcsolati közeg (Kitwood eredeti fogalmával malignant social psychology) ott kezdődik, ahol a szakember a diagnózist látja először, és a személyt másodszor.

A DEEP-mozgalom ezt egy lépéssel tovább viszi: „nothing about us without us” — az érintetti hang a saját ellátásáról nem opció, hanem alap. Kate Swaffer és a brit DEEP-hálózat ezt living beyond dementia keretként fogalmazza meg.

2. Az érzelmi igazság elsőbbsége a ténybeli felett

Feil 1993-as Validation Breakthrough-ja és Snow PAC-keretrendszere itt találkozik: a „hol az anyám?” kérdésre a ténybeli válasz („meghalt”) szinte sosem a helyes válasz. Az érzelmi igazság az, hogy hiányzik az érintettnek egy biztonságot adó alak.

Ez nem hazugság, hanem érzelmi tükrözés. De a határ vékony — a 7. fejezetben (és a 6. helyzetnél a vád részben) konkrét hibákat is megnevezek.

3. A non-pharmakológiai intervenció az első vonal

A 2024-es Lancet Commission (Livingston et al.) és a Kales-féle DICE-keret (2015) egyértelműen állítja: a BPSD első vonalbeli kezelése non-pharmakológiai. Az antipszichotikum csak akkor indikált, ha (a) a biztonság akut veszélyben, (b) a non-pharmakológiai protokoll dokumentáltan eredménytelen, vagy (c) specifikus indikáció áll fenn (pl. major depresszió).

A magyar valóságban ez sokszor fordítva történik. A kódex célja nem a rendszerprobléma megoldása, hanem hogy a kommunikációs intervenciókat világosan ki tudjuk jelölni — hogy a szakmai döntéshozó tudja, mit nem próbáltunk még.

I. Az ismétlő kérdés (negyedik alkalommal)

A helyzet a gyakorlatból. A lakó tizenötödször kérdezi meg, hány óra van. A nővér eleinte türelmes, aztán éles lesz. A lakó érzi a hangsúlyt, és gyakrabban kérdez. A hozzátartozó otthon ugyanezt éli — „most mondtam, anya” → szégyen → még több kérdés.

Mit mond a négy iskola. Kitwood szerint ez nem memóriadeficit, hanem a comfort és az attachment szükségletének jelzése — szorongás, kontrolligény. Feil time confusion fázisba sorolja: az érintett kilépett a kronológiai időből. Snow GEMS-modelljében ez tipikusan az Emerald állapot — célt akar, de a tér- és időbeli orientáció már sérül. A DEEP-perspektíva pedig azt teszi hozzá: az érintettnek joga van nem tudni az időt anélkül, hogy szégyennel találkozzon.

A magyar adaptáció. Az ismétlő kérdés mögött nem a kérdés van, hanem egy érzés: valami történni fog, és nem tudom, mi. Ezt magyar családokban különösen erősen árnyalja a generációs kötés — a kérdés sokszor úgy hangzik, „mikor jön a Pista” (a már elhunyt férj). A klasszikus magyar válasz („meghalt, anya”) reaktiválja a gyászt minden alkalommal.

Amit kollegiálisan megosztok. Először rövid, nyugodt válasz, ítékezés nélkül. Utána átvezetés egy közös tevékenységbe — séta, tea, képnézegetés. Ha a kérdés mögötti érzés azonosítható (mintha várnánk valakit), arra is válaszoljunk: „nem várunk senkit, együtt vagyunk”. A hozzátartozói edukációban én csak egyetlen mondatot adok haza: a következő héten próbáld ki, hogy nem mondd ki azt, hogy „most mondtam”. Egy technika egyszerre.

2. A tévhitek és vádak (lopás, megtevesztés)

A helyzet a gyakorlatból. „Elloptátok a gyűrűmet!” A nővér tudja, hogy a gyűrű az éjjeli szekrényben van. Megmutatja. A lakó tagadja, hogy az övé lenne. A vád megismétlődik másnap is. Otthon ugyanez: az anya a fiát vádolja, hogy elvitte a nyugdíját.

Mit mond a négy iskola. Kitwood szerint itt két szükséglet sérült: az inclusion (bevontság a saját életében) és az identity (a kontroll a saját tárgyai felett). Feil ezt a malorientation fázisba sorolja — az érintett még tájékozott, de a veszteségeit másokra projektálja. Snow PAC-keretrendszerében a vád egy Diamond–Emerald határtünet: az éles, merev gondolkodás már nem tudja kitölteni a hézagokat. A DEEP-irodalomban (Swaffer) ez markánsan jelen van: a vád nem személyes, hanem a zavaros világ elleni jelzés.

A magyar adaptáció. A magyar családi dinamikában a vádaskodás külön súlyt kap, mert a megbecsülés kulturális elvárása erős. Ha az anya a fiát lopással vádolja, a fiú gyakran a saját jellemén kéri számon: én ezt érdemlem? Ezt érdemes a hozzátartozói konzultációban explicit megnevezni: a vád nem a fiú ellen szól. A zavaros világ ellen.

Amit kollegiálisan megosztok. Ne védekezzünk, ne bizonyítsunk. Csatlakozzunk: „Hadd nézzem meg veled, hol lehet.” Közös keressük. Amikor megvan, nem mondjuk meg, hogy ott volt mindig. „Nézd, itt van. Tedd vissza biztonságos helyre.” A keresés maga adja vissza a kontrollt. Ez Feil 11-es technikája (linking behavior to need) tisztán: a viselkedés mögé tedd a szükségletet.

3. A BPSD non-pharmacological első vonala

A helyzet a gyakorlatból. Délután 4 óra, intézményi környezet. A lakó addig nyugodt volt. Most felkel, indul az ajtó felé, hangosabban beszél, indulatos lesz. A nővérstáb 10 perces ablakban dönt: nyugtató, vagy más. A háziorvosi vizit holnap, a család panaszt tett tegnap.

Mit mond a négy iskola. A 2024-es Lancet Commission (Livingston et al.) és a Kales-féle DICE-modell (Describe-Investigate-Create-Evaluate) konszenzusa: az első vonal non-pharmakológiai. Kitwood comfort check-je, Snow PAC-protokollja, Feil centering-technikája, és Brooker VIPS-frameworkje mind ide tartoznak. A DEEP-perspektíva pedig: az érintettnek joga van nem nyugodt lenni a saját ritmusában — a sundowning nem patológia, hanem napszakvariabilitás.

A magyar adaptáció. A magyar geriátriai gyakorlatban a nyugtató-először alapminta erős. Ennek nem az orvos a hibás — a strukturális ok az, hogy a non-pharmakológiai intervenció időigényes, és a magyar ellátásban az időre nincs finanszírozási kódszám. A kódex célja nem a rendszerprobléma megoldása, hanem hogy dokumentálhatóan ki tudjuk jelölni a non-pharmakológiai lépéseket.

Amit kollegiálisan megosztok. Egy ötszintű hierarchiát ajánlok — Brooker VIPS, Snow PAC, és a DICE szintézise: (1) comfort check — fájdalom, éhség-szomjúság, WC, ingerszint; (2) validation + PPA — érzelmi tükrözés, lassú belépés, ráhangolódás; (3) environmental adjustment — fény, zaj, ingercsökkentés; (4) activity engagement — célzott elfoglaltság; (5) pharmacological consultation — geriáterrel, csak ekkor. A comfort check önmagában a problémák 40–60%-át megoldja a klinikai gyakorlatban. Ezt érdemes a kollégáknak (és a háziorvosoknak) explicit kommunikálni.

4. A fürdés / öltözés ellenállása (Hand-under-Hand)

A helyzet a gyakorlatból. A nővér bemegy fürdetni. A lakó ordít, eltol, ütésre emeli a kezét. Két nővér próbálja megfogni. A jelenet eszkalálódik. A hozzátartozó otthon ugyanezt éli: az apa nem hagyja, hogy a fia segítsen a zuhanyzásnál.

Mit mond a négy iskola. Kitwood szerint a fürdetés a comfort legtisztább próbája — az intim érintés vagy biztonságot ad, vagy fenyegetést. Feil 13-as technikája (touch) ezért külön kategória: kulturálisan érzékeny, és magyar idős férfi pácienseknél az arcérintés sokszor túl intim. Snow itt fejlesztette ki a Hand-under-Hand (HuH) technikát: a gondozó tenyere alulról fogja meg az érintettét — anatómiailag a hüvelykujj-él stimulációja megnyugtat, pszichológiailag a „te vagy felül” érzés visszaadja a kontrollt. A DEEP-perspektíva ehhez hozzáteszi: az engedélykérés (PPA P6) nem formalitás, hanem alapjog.

A magyar adaptáció. A magyar ápolásban a kézfogás vagy a karon vezetés a default — mindkettő dominanciát közvetít. A HuH alig ismert, a magyar szakirodalomban alulfogás vagy segítő tenyér néven jelenik meg ritkán. Ezt érdemes nővérképzésben testileg megtanítani — szóbeli leírásból nem megy. Snow azt mondja: minimum 50 ismétlés kell, hogy a mozdulat ne legyen gondolkodás kérdése.

Amit kollegiálisan megosztok. Először kapcsolódás: név, mosoly, lassú érintés a vállnál (Feil 10-es, mirroring). Utána bejelentés egyszerű mondattal (Snow PPA P5): „most a vizet megnyitom”. Utána engedélykérés (PPA P6): „megengedi, hogy a kezéhez érjek?” — akkor is, ha napi rutin. Utána HuH-vezetés. A meleg víz, a meleg szoba, az ismerős illat — Kitwood comfort-rétege. Ha intézményben vagy: ezt érdemes nővérstábi képzésben, gyakorlattal tanítani — videóval, szerepjátsékkal.

5. Az „itt akarok hazamenni” mondat

A helyzet a gyakorlatból. A lakó nyugtalan, az ajtó felé indul, ordít: „Haza akarok menni.” A nővér próbálja meggyőzni, hogy itthon van, itt él. A lakó hangja erősebb lesz. Otthon a hozzátartozó ugyanezt éli — az anya 30 éves saját lakásában mondja, hogy haza akar menni.

Mit mond a négy iskola. A „haza” nem földrajzi hely. Kitwood szerint az attachment-szükséglet jelez: a biztonságot adó kapcsolat valamikor érzett, most elveszett. Feil time confusion fázisnak nevezi: az érintett a saját belső idejében él, gyakran a fiatakorában. Snow GEMS-modelljében ez az Emerald állapot — céltudatos, de orientációvesztett. A DEEP-irodalomban Kate Swaffer ezt úgy fogalmazza: az otthon, amire emlékszik, már nem létezik.

A magyar adaptáció. A „haza” a magyar érintetteknél különösen gyakran a gyerekkori falu, a háború előtti lakás, vagy egy már elhunyt szülő otthona. A ténybeli korrekció („ott már nem laksz, anya”) nem segít — sokszor a gyászt aktiválja újra. Az ajtózáras (magyar időotthonokban gyakori) eszkalációhoz vezet. Az „itthon van” mondat magyarul különösen problémás, mert a magyar nyelvben az „itthon” erős érzelmi töltetű.

Amit kollegiálisan megosztok. A „haza” érzését újrateremtjük itt. Egy ismerős hang, egy ismerős tárgy a táskájából, fél kávé, egy „meséld el, milyen volt otthon” kérdés (Feil 6-os, reminiscing). A cél nem az, hogy elfogadja, hogy itt van. A cél, hogy itt is otthon legyen pár percig. A hozzátartozónak: ne korigálj, ne magyarázd. Csatlakozz az érzelmi igazsághoz.

6. A családdal való kommunikáció (a DICE keret)

A helyzet a gyakorlatból. A család panaszkodik: anya megváltozott, agresszív lett, már nem ugyanaz az ember. A házi orvos antipszichotikumot ír. A család megnyugszik egy hétre. A következő hónapban újabb tünet jön. A geriáter konzultáción te ülsz velük szemben — és érzed, hogy a család nem informálisan szól vissza, mert nem mer.

Mit mond a négy iskola. Kitwood szerint a család az érintett szociálpszichológiai terének része — a károsító kapcsolati közeg sokszor itt kezdődik, a védekező-túlcsorduló gondoskodásban. Feil a hozzátartozói tréninget kezdetektől a módszer részeként kezelte. Snow PAC-rendszerében külön Care Partner program van. A Kales-féle DICE-modell (Describe-Investigate-Create-Evaluate, BMJ 2015) pedig egy strukturált keretet ad: a családdal együtt írjuk le a viselkedést, vizsgáljuk az okát, alakítunk ki tervet, és értékelünk.

A magyar adaptáció. A magyar családi rendszerben a koordinátor szerep gyakran egy gyerekre (általában a lányra) terhelődik, kiegészhez vezet. A családi konzultáció formátum — 60 perc, három téma: (a) aktuális állapot, (b) három hónap prioritásai, (c) ki mit vállal — még a legszorongóbb magyar családoknál is megnyugvást hoz. A DICE négy lépésén végigvinni a családot strukturáltan: a Describe különösen fontos — a magyar családok hajlamosak a „rosszul viselkedik” általánosításra.

Amit kollegiálisan megosztok. Először a saját élményüket validáld. Mielőtt a technikákról beszélnél, kérdezd: „Mi a legnehezebb most? Mi az, ami téged kimerít?” Ha az ő érzelmi igazságát nem validálsz először, a validation mint technika hiteltelen lesz. Egy konkrét eszköz: a hatos lista — kérd meg a családot, nevezzen meg 6 dolgot, amit a szeretett személye még szeret csinálni. Ez lesz az occupation-térkép, és sokszor önmagában terápiás a hozzátartozónak. A good enough caregiver (Bowlby-Winnicott analógia) hiedelme — ha jól csinálnám, nem lennék kimerült — explicit meg kell nevezni és el kell vetni.

7. Az interdiszciplináris interfész

A helyzet a gyakorlatból. Az érintett útja: háziorvos → neurológus vagy pszichiáter → (esetleg geriáter) → szociális szolgáltatás → szakosított ápolási otthon. Hozzátapad: gyógytornász, foglalkozásterapeuta, demencia-mentor, lelkipáter. Az interfész-pontokon — ahol az egyik szakember átadja a másiknak az érintettet — diszkrepancia keletkezik. Az egyik kolléga azt mondja X, a másik Y. A család összezavarodik.

Mit mond a négy iskola. Kitwood VIPS-frameworkje (Brooker 2007 továbbfejlesztésében) az intézményi-szervezeti dimenziót is beemeli: a values, individual, perspective és social szintű összehangolás nem opcionális. Fejl a Validation Worker, Validation Practitioner, Validation Master hármas-szintű képzéssel próbálja az egységességet biztosítani. Snow PAC International ugyanezt a Train-the-Trainer modellel. A DEEP-mozgalom pedig az érintetti kontrollt teszi középpontba: az átadás az érintettel együtt történjen, ne fölötte.

A magyar adaptáció. A magyar kórlapból tipikusan hiányzik az a típusú információ, ami egy demens érintett kommunikációs profiljához kellene. A Nemzeti Demencia Stratégia 2018–2030 keret ad, de a gyakorlati implementáció egyenetlen. A háziorvosok jelentős része nem ismeri a Lewy-szenzitivitást — egy egysoros átadási megjegyzés („Lewy-gyanú esetén kérjük a haloperidol kerülését”) szakmailag hasznosabb, mint egy generikus emlékeztető.

Amit kollegiálisan megosztok. Egy egyoldalas demencia-kommunikációs profil az átadás minimumstandardja lehetne. Javasolt elemek: életrajzi sűrítvény (3 mondat a legfontosabb élményekről, szerepekről), aktuális Snow-állapot (pl. reggel Emerald, délután Amber-felé csúszik), mi nyugtatja (egy dal, egy ima, egy étel, egy fotó), mi zaklatja fel (konkrét trigger), hozzátartozói rendszer (ki a fő kapcsolattartó). Ez nem kórlap-pótló — kiegészítő. Ha intézményben dolgozol: érdemes negyedévente egy 45 perces shift-eligazítást tartani a szociális gondozóknak, egy konkrét érintett körül járva be a PPA-, validation-, comfort check-eszköztárat.

8. A nyelv, ami stigmatizál — és ami segít

A helyzet a gyakorlatból. A kórlapon szerepel: „a dement az ágyban”. A háziorvosi referálásban: „demens néni”. A családi beszélgetésben: „anya már nem az anya”. Minden mondat egy mikrosérülés — az érintett személy-mivolta halványul.

Mit mond a négy iskola. A DEEP-hálózat 2014-es Dementia Words Matter irányelve (revízió 2020) konkrét listát ad a kerülendő és ajánlott szóhasználatra. Kitwood ezt károsító kapcsolati közegnek nevezte: az infantilizálás („aranyoskám”), az objektivizálás („etetni kell a 14-est”), a kihagyás (jelenlétében róla beszélni harmadik személyben). Feil ezért javasolja a centering technikát: mielőtt belépsz a kapcsolatba, vegyél magadnak egy pillanatot — különben a nyelv automatikusan a fáradtság nyelve lesz. Snow PAC-rendszere a person-first language-et alapnak veszi.

A magyar adaptáció. A „dement” mint főnév („a dements az ágyban”) végleg kerülendő — még a kórlapon is. A „demenciával élő ember” hosszabb, kényelmetlenebb — és pontosan ezért hordoz tiszteletet. Néhány konkrét magyar terminus, ami szerintem vita-érett: person-centred care → személyhez méltó ellátás (a centred földrajzi felhangja gyengíti az etikai töltetet); personhood → személy-mivolt (nyitott); sundowning → napszaki romlás a tünetre, napszakvariabilitás a jelenségre; positive physical approach → megerősítő testi közelítés (a pozitív túlmarketinges).

Amit kollegiálisan megosztok. A terminológia nem semleges — ahogy nevezünk valamit, az formálja a klinikai gondolkodást. Ezt érdemes a saját csapatodban explicit megbeszélni. Egy konkrét gyakorlat: a következő stábmegbeszélésen kérdezd meg a kollégákat, melyik szót használjátok automatikusan, és melyiken érdemes elgondolkodni. Nem szabálykönyv kell — közös reflexió.

9. A kollegiális szupervízió-kör

A helyzet a gyakorlatból. Te vagy a kórház geriáter főorvosa, vagy egy idősothton ápolásvezetője, vagy egy demencia-mentor szabadúszó praxisban. A heti gyakorlatból összegyűlnek a nehéz esetek — és nincs hová tenni őket. A magyar demencia-szakmában nincs széles körű peer-szupervíziós kultúra. Te magad gyakran a legkompetensebb ember vagy a szobában — és ettől fáradtabb.

Mit mond a négy iskola. Feil a Validation Master-szintű képzésben kötelező szupervíziót ír elő. Snow PAC-rendszerében Coach és Mentor szerepek vannak. Kitwood-Brooker VIPS-frameworkje az intézményi reflective practice-t alapnak veszi. A DEEP-hálózat pedig kifejezetten épít a peer-támogatásra — az érintettek és a szakemberek között is.

A magyar adaptáció. A magyar demencia-szakma kicsi: néhány száz ember összesen. Ezért minden szakmai kapcsolat számít, és ezért különösen kínos, hogy a peer-szupervíziós kultúra hiányzik. A „majd a család megoldja” delegáció szakmailag az egyik leggyakoribb csapda — de a „majd én megoldom egyedül” delegáció a saját pszichénk felé legalább ennyire problémás.

Amit kollegiálisan megosztok. Tíz önreflexiós kérdés, amit időről időre érdemes magaddal végigvenni:

1. Mikor utoljára egy interakció után fáradtabb voltam, mint amennyit a feladat megért?
2. Ismerem-e a saját három „nem mehet alá” tünetszintemet — testi, érzelmi, szakmai?
3. Mikor utoljára nem értettem egyet egy másik szakemberrel egy érintett ügyében?
4. Van-e olyan érintetem, akinek a kommunikációs profilját évek óta nem frissítettem?
5. Mikor utoljára kértem konkrét visszajelzést egy kollégától a saját kommunikációs gyakorlatomról?
6. Melyik az a hozzátartozói típus, akivel rendszeresen nehezebb dolgoznom?
7. Ha holnap újrakezdhetnék, melyik technikát tartanám meg, melyiket engedném el?
8. Mennyit olvasok a saját szakterületemen évente — mély olvasásban?
9. Van-e valódi supervízom — egy nálam tapasztaltabb szakember?
10. Mikor utoljára megkérdeztem egy demens érintettet, hogy ő mit gondol a saját helyzetéről?

Mit ajánlok kollegiális szinten

Ez a kódex nem páciens-toborzó csatorna. Ha eddig olvastad, valószínűleg neked is több páciensed van a kezeden, mint amennyi belefér. Amit ehelyett ajánlok három formában:

- 1. Szakmai szupervízió-kör.** 2026 őszétől havi egyszer, online, 90 perces, maximum 8 résztvevős kollegiális esetmegbeszélő kör. A formátum: két előzetesen beküldött eset, strukturált megbeszélés, írásos összegzés. A részvétel kollegiális — nem hierarchikus. Költségtérítéses (platform és adminisztráció fedezésére), nem nyereség-orientált.
- 2. Ko-edukációs együttműködés.** Ha intézményi vagy közösségi szinten demencia-educációt csinálsz — családi tréning, ápolói képzés, civil esemény — és hasznosnak tartanád egy második szakember bevonását egy közös előadásra, workshopra vagy anyag-fejlesztésre, szívesen beszélgetek erről. Az érdekem ebben nem a saját láthatóságom növelése, hanem a magyar demencia-educáció egységesebb minőségi szintje.
- 3. Konferencia- és írott-anyag-hálózat.** Egy informális szakmai listát építünk azokról a magyar szakemberekről, akik nyitottak konferencia-meghívásokra, közös írott anyagok lektorálására, vagy szakmai levelezésre. Ha érdekes, jelezd.

Kapcsolódási pont

- **E-mail kollegiális megkeresésre:** hello@vivien.hu — kérlek, írd a tárgyba: „Kollegiális — kódex”.
- **A 2026-os szakmai naptáram és a szupervízió-kör részletei:** vivien.hu/szakembereknek
- **LinkedIn:** Stoiber Vivien — szakmai cikkek, konferencia-megosztások

Sokszor a kompetens emberek a legkevésbé láthatók ebben a térben. Ha ezt a kódexet végigolvastad, akkor te is az a magyar demencia-szakember vagy, aki nem feladta — aki nem csúszott bele a rutinba, aki még mindig kérdez, aki még mindig olvas, és aki még mindig hiszi, hogy a magyar demencia-ellátást lehet jobbra tenni.

Ezt nem becsülöm le. Köszönöm.

Hálával, Vivien

- Kitwood T. *Dementia Reconsidered: The Person Comes First*. Open University Press, Buckingham, 1997.
- Feil N. *The Validation Breakthrough: Simple Techniques for Communicating with People with Alzheimer's-Type Dementia*. Health Professions Press, 1993 (revízió: 2002, 2012).
- Snow T. *Positive Approach to Care — Training Manuals & GEMS States*. PAC International, Efland (NC), folyamatos kiadás.
- Brooker D. *Person-Centred Dementia Care: Making Services Better with the VIPS Framework*. Jessica Kingsley Publishers, London, 2007 (revízió: 2019).
- Livingston G, et al. *Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission*. *The Lancet*, 2024;404:572–628.

- Kales HC, Gitlin LN, Lyketsos CG. *Assessment and management of behavioral and psychological symptoms of dementia*. BMJ, 2015;350:h369. — a DICE-modell alapcikke.
- DEEP. *Dementia Words Matter: Guidelines on Language about Dementia*. DEEP Network, 2014 (revízió: 2020).
- Swaffer K. *What the hell happened to my brain? Living beyond dementia*. Jessica Kingsley Publishers, 2016.